

☒ ACOMPANHAMENTO		☐ CONSULTA	
NS 22231697080		807	
ESTEFANIA MENEZES HENRIQUE			
IDADE: 35	PESO: 124	ALTURA: 1,60	PROFISSÃO: Analista Adm.
SINTOMAS: Dorco, Apagões durante o dia;			
QUEIXAS: disputa a noite			
MEDICAMENTOS: -			
vitaminas D+3			
MÉDICO: Dra Camila Canava - Clínica opus			
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N			
EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana.			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME:		HORA QUE ACORDA:	
COCHILLO () SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO			
FUMO () SIM () NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO: 3x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI: IV	IAH: 121,4	SPO2: 66% mínimo SPO2: 88% média
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Sim → Simult + Covid 2022 - piora sono.			
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS			
19/02 Adaptação másc. Mirage Rx			
24 P = 5 - 13 cmH ₂ O			
26/02 P = 11,1 (med) / Perc. 12,9 cmH ₂ O			
24 IAH = 1,0 e/ev melhora do quadro de sonolência - sua.			
mde uso: 8h.			
25/03 P = 11 cmH ₂ O Bem adapt.			
24 IAH = 0,8 e/ev			
m. de uso: 6h			
15/04 P = 11 cmH ₂ O sua mudar a rotina			
24 IAH = 0,7 e/ev 1º exere. 30'			
m. de uso: 5h45' 2º exere. 1h00'			
15/05 P = 11 cmH ₂ O Bem adapt.			
24 IAH = 0,7 e/ev sua.			
m. de uso: 5h45'			
12/06 P = 11 cmH ₂ O			
24 IAH = 0,7 e/ev			
m. de uso: 6h30'			
Fuga 14,4 lpm R\$ 3500, (÷ 2) sua			

19/06 P = 11 cmH₂O

24

IAH = 0.7 e/h

m. de uso: 5.46

fuga = 17.7 lpm.

comprou o CPAP.

dua

15/07

24

P = 11 cmH₂O

IAH = 0.8 e/h

m. de uso: 6h 17'

Fuga = 14.7

↓ unidif.

dua

27/09/24 P = 11 cmH₂O

IAH = 0.6 e/h

m de uso: 5h 47'

Natacha

22/11/24 P = 11 cmH₂O

IAH = 0.8 e/h

m de uso: 6h 24'

fuga: 13.2 l/m

Natacha

27/06

25

P = 11 cmH₂O

IAH = 0.8 e/h

M. de uso = 6h 35'

fuga = 9.8 lpm.

Bem adaptado

dua.

Nome: ESTEFANIA MENEZES HENRIQUE

Data de Nascimento: 8-6-1988

IMC: 48,44

Sexo: Feminino

Data do exame: 06-01-2024

Peso: 124 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DRA. LUCIANA ABIFADEL

LAZZARINI VAZ

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 06-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 491,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 98,5 e 67,5 minutos. O tempo total de sono foi de 377,5 min, eficiência de 76,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,3%; estágio N2: 70,7%; estágio N3: 5,6%; sono REM: 22,4%. O índice de despertares foi de 71,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 121,4/hora, sendo 45 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 596 hipopnéias. A SpO2 média foi de 88% e a mínima de 66%, permanecendo 34,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 107 bpm e NREM de 53 - 110 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (21), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 121,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=66%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM aumentada;
6. aumento número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

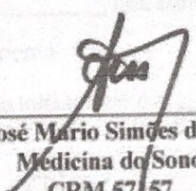
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57